

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	T-tube 管路護理 Nursing Care of T-tube Drainage				
編號	A31000-Q02-W-C10	制定者	SI 柯亦芳	公布日期	99 年 04 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 3.3 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

使護理人員能了解並正確執行 T-tube 管路的護理。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

1. 保持傷口清潔，預防傷口感染及早期發現感染徵象。
2. 觀察傷口是否有出血及滲液情形。
3. 維持管路通暢及預防管路滑脫。

（二）用物準備

1. 治療盤。
2. 治療巾。
3. 無菌敷料鉗及泡鏟罐各一個。
4. 消毒溶液：生理食鹽水及優碘藥水（視傷口及敷料種類來選擇）。
5. 傷口換藥包（內含：有齒鑷、無齒鑷及換藥碗各一個）。
6. 消毒棉棒數包或棉球（視傷口狀況選擇種類或尺寸）。
7. 3x3 Y 紗一包。
8. 清潔手套。
9. 3M 透氣膠帶。
10. Mefix。

主題名稱	T-tube 管路護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C10	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	2/7

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對 HIS 系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
2. 洗手。	
3. 備妥用物，將換藥車（或護理工作車）推至病人單位。	
4. 辨識病人(至少二種以上方法)，向病人及家屬解釋換藥的部位及過程。	(1) 辨識方法請依照「病人辨識作業作業標準執行」。 (2) 確認病人，建立安全感，取得病人信任。
5. 拉上床簾，露出傷口部分。	
6. 以治療巾墊於傷口下。	
7. 移除膠布及敷料： (1) 戴上清潔手套，一手固定皮膚，另一手由膠布兩側往傷口的方向，輕輕地撕下膠布。 (2) 抓住敷料的最外層輕輕取下。 (3) 檢視取下的敷料，觀察分泌物的量、氣味及顏色。 (4) 將敷料抓在手上，脫下手套將其包起來，丟至紅色感染性垃圾筒。	若傷口與敷料發生沾粘，可用生理食鹽水濕潤後再取下，以防止傷害新長出來的肉芽組織。
8. 使用乾洗手液消毒雙手後，戴上清潔手套。	
9. 清潔與消毒傷口：(以無菌棉棒為例) (1) 以無菌技術打開包裝及取出無菌棉棒。 (2) 先用沾有生理食鹽水的棉棒由內往外環形清洗，連續清洗直到拭淨為止。 (3) 再以沾有優碘的棉棒消毒傷口 2-3 次，使優碘溶液停留在傷口時間至少達 30 秒以上（重點是停留時間，而不是要消毒幾次）。 (4) 以生理食鹽水棉棒由內往外環形清洗，連續清洗直到優點溶液拭淨為止。 (5) 最後以乾棉棒將傷口周圍皮膚的溶液擦乾。	(1) 清洗及消毒範圍至少大於傷口直徑 5cm，清洗完後可執行傷口觀察及測量。 (2) 消毒棉棒由內往外擦拭一次後即丟棄，切記勿來回擦拭，以防止污染傷口。
10. 先以 Y 紗先固定管路，Mefix 上下固定敷料，再用小捲 3M 透氣膠帶固定引流管，最後以 Mefix 將引流管固定於體表平坦處。	(1) 貼膠布的方向與肌肉走向呈垂直（較易固定）。 (2) 敷料應大於傷口直徑 5 公分，以免傷口受污染。 (3) 固定引流管時需注意不要讓病人容易壓到或扯到，亦不影響病人上下床的位置。
11. 協助病人整理衣物及單位。	

主題名稱	T-tube 管路護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C10	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
12.清潔，整理及補充用物。	
13.工作後洗手。	
14.在 HIS 系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”及計價。	
15.記錄：敷料滲出液的顏色、量及性質；傷口及周圍皮膚有無紅腫情形；引流液的顏色、量及性質。	

(四) 異常狀況處理說明

異常狀況	處理對策
滑脫： T-tube 滑脫（包含自拔）可能原因： 1. 病人意識不清、躁動、不適等因素造成滑脫或自拔。 2. 不小心拉扯。 3. 膠布固定不佳引起。	1. 當滑脫時，應先以無菌紗布覆蓋。 2. 立即通知醫師。 3. 衛教病人或主要照顧者 T-tube 存放的必要性與重要性，並評估管路擺放的適當性，避免拉扯。 4. 評估約束的必要性。 5. 於 HIS 系統完成異常事件通報。
折曲： 可能原因：反折和纏繞。	使用安全別針將引流袋固定於衣服腰側處，應低於管路置放處。
感染症狀：傷口周圍紅腫熱痛或發燒之情形。	1. 若發現病人有感染徵兆，評估病人狀況，是否需做立即處理。 2. 發現感染立即通知醫師，評估是否需要拔除。 3. 通知醫師，評估是否需抽血、做傷口細菌培養、抗生素使用等。

(五) T-tube 管路的放置和注意事項

管路的放置和注意事項	說明
1. 隨時注意管路是否通暢，避免受壓、扭曲，保持引流管傷口清潔乾燥。	
2. T-tube 尺寸：16.18.20.22 Fr。	
3. 放置位置：醫師打開總膽管並將 T 型管縫入總膽管內，T 型管的短端朝向肝管和十二指腸，長端從靠近傷口之處出來與皮膚縫在一起，貼上膠帶使之牢固，避免管路拉扯，若縫線滑脫，應立即通知醫護人員。	圖示： 

主題名稱	T-tube 管路護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C10	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	4/7

管路的放置和注意事項	說明	
4. 正常情況下膽汁會逐漸變成金黃色，每日需記錄引流液的量及顏色，引流量每天約 400c.c.，若超過 1000c.c.則須通知醫師。出院時，若管路帶回，需衛教病人請每日記錄引流液的量及顏色。 5. 若引流液量超過引流袋的 1/3-1/2，則需倒出。	圖示：	
6. 臥床休息時，採半坐臥式，維持引流袋低於管路放置處，請將引流袋掛於床邊的掛勾上，以免下床時不小心踩到引流袋，而使管路受到拉扯而脫落。 7. 管路勿放置於地上，以避免感染。	圖示：	
8. 下床活動時，請保持引流袋管路放置處，以免膽汁回流造成感染，並避免不小心的拉扯使管路外滑、脫落或傷口出血。	圖示：	

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林貴滿(2007)·消化系統疾病病人之護理·胡月娟總校閱，內外科護理學(一版，593-778 頁)·台北：華杏。
- (二) 孫宜欣、蔡麗紅、藍素珍(2012)·一位罹患膽結石術後併發膽道阻塞病患之護理經驗·長庚科技學刊，16，61-70。

主題名稱	T-tube 管路護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C10	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	5/7

七、附件

(略)

主題名稱	T-tube 管路護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C10	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.04.20	1.0	新制定。	99 年 04 月 20 日 護理部照護標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.04.06	2.1	修改目的與說明內容。	100 年 04 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
101.06.06	2.2	修改目的。	101 年 06 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.02	3.1	1. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 2. 第三項第（四）目異常狀況處理說明部份刪修。 3. 新增第六項參考資料。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過
105.06.07	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.06.05	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	3.2	第三項第四目異常狀況處理說明：新增感染的處置 對策	107 年 06 月 13 日 護理長會議通 過。
108.06.06	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會 議通過公布。
109.06.04	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

